

Gynéco-Obstétrique — Sujet n°4 (SF L2)

EVALUATION DES ELEVES SAGE-FEMMES

NIVEAU L2

SUJET 4

QUESTIONS A CHOIX DIRECT : Répondre par Vrai (V) ou Faux (F)

La CPN recentrée ne concerne que les grossesses à risque (F)

L'éclampsie se définit comme un syndrome convulsif survenant chez une femme enceinte en travail (F)

La CPN du 3e trimestre permet d'évaluer le pronostic d'accouchement par voie basse (V)

La MAP se définit par une modification du col associée à des contractions utérines, survenant entre 20 SA et 30 SA (F)

Le sulfate de magnésium permet la prévention de la crise d'éclampsie (V)

La rupture utérine fait partie des causes de métrorragies du 2e trimestre (V)

La SFA se traduit par une altération du rythme cardiaque fœtal et un RCIU (F)

La délivrance artificielle est l'exploration manuelle de la cavité utérine, après l'expulsion du placenta (F)

La découverte d'un placenta incomplet à l'examen impose une révision utérine (V)

La GATPA permet d'augmenter le délai de la délivrance (F)

La révision utérine est l'extraction manuelle du placenta hors des voies génitales maternelles après l'expulsion du fœtus (F)

L'anémie au cours de la grossesse se définit par un taux d'hémoglobine $<10,5$ grs /100 ml au 1er et 3ème trimestre de la grossesse (F)

L'évolution de la grossesse molaire ne se fait jamais vers l'avortement molaire (F)

La GATPA permet de diminuer les pertes de sang en augmentant l'hématome retro placentaire physiologique (F)

La délivrance artificielle est l'exploration manuelle de la cavité utérine, après l'expulsion du placenta (F)

Devant une rétention placentaire complète, on doit pratiquer une délivrance dirigée. (F)

La GATPA permet de diminuer les pertes de sang en réduisant l'hématome retro placentaire physiologique (V)

La procidence du cordon est une chute du cordon en avant de la présentation à membranes intactes (F)

Devant un avortement molaire, la sage-femme doit prendre une voie veineuse et réaliser l'AMIU en salle d'accouchement (F)

Dans l'HRP, l'étiologie la plus rencontrée est le traumatisme abdominal (F)

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE : Choisissez la ou les bonnes réponses

Citez les facteurs favorisant la procidence du cordon :

Présentation du siège

Présentation céphalique

Présentation transversale

Grossesse gémellaire

Quels sont les gestes à faire en cas de procidence du cordon battant :

Recouvrir le cordon avec des compresses sèches

Installer la patiente en position de Trendelenburg

Faire des TV pour surveiller la descente du fœtus

Hospitaliser la patiente

Donner les signes de la pré éclampsie :

HTA

Convulsions généralisées

OMI

Troubles visuels

Macrosomie

Donner les complications de la pré éclampsie

Mort fœtale

RCIU

Anémie

OAP

Le placenta prævia se traduit par les signes suivants :

BDCF présents

Signes de choc non en rapport avec les saignements

Col cerclé

Perception d'un matelas placentaire

Les signes suivants sont retrouvés le plus souvent dans la rupture utérine :

BDCF présents

Col cerclé

Présentation fœtale inaccessible au TV

Fœtus perçu sous la peau

Quels sont les complications liées à l'HRP :

Choc hypovolémique

Atonie utérine

Fièvre

Décès

Quels sont les signes en faveur d'un HRP :

Fœtus vivant

Contracture utérine permanente

Col cerclé

Présentation inaccessible au TV

Sang noirâtre, minime

Les différents placentas observés au cours du travail sont :

Le placenta prævia recouvrant

Le placenta prævia central

Le placenta non recouvrant

L'élément (ou les) suivant (s) fait (ou font) partie des facteurs de risque de l'hémorragie de la délivrance :

Antécédent d'hémorragie de la délivrance

Primiparité

Grossesse extra utérine

Dans quelle pathologie l'hypertension artérielle est-elle un facteur favorisant :

Le placenta praevia

L'hématome retro placentaire

La rupture utérine

L'évaluation du bien-être fœtal est appréciée par :

Le rythme cardiaque fœtal

Degré de modelage de la tête

Le niveau de la présentation fœtale

La grossesse extra-utérine est :

Une grossesse qui peut évoluer jusqu'à terme

Une prolifération anormale du trophoblaste

De localisation abdominale dans la majorité des cas

L'implantation de l'œuf en dehors de la cavité utérine

Quels sont les signes cliniques en faveur d'une GEU ?

L'utérus est augmenté de volume

Des métrorragies minimales sépia

L'œuf est perçu sous la peau

Masse latéro-utérine

Les métrorragies du premier trimestre doivent évoquer en premier lieu :

Une grossesse arrêtée

Une GEU

Une grossesse molaire

Une rupture utérine

Les examens sanguins faisant partie du bilan biologique de la CPN sont :

Groupes sanguins et Rhésus

ECBU

Électrophorèse des protéides sanguines

Uricémie

Ag HBe

Donner les signes d'éclampsie :

Douleur en barre épigastrique

Convulsions généralisées

Flou visuel

Troubles sensitifs

Macrosomie

Quelle est l'étiologie la plus rencontrée dans les HPPI ? cochez la bonne réponse

Rupture utérine

Troubles de la coagulation

Atonie utérine

Thrombus vulvaire

Quels sont les gestes à faire en cas de procidence du cordon battant :

Recouvrir le cordon avec des compresses sèches

Installer la patiente en position de Trendelenburg

Faire des TV pour surveiller la descente du fœtus

Hospitaliser la patiente

Parmi les éléments suivants, lesquels ne font pas partie de la GATPA :

Massage utérin

Traction contrôlée du cordon

Révision utérine

Vidange vésicale

Injection de 5UI de Syntocinon en IM